

DLBCL / CNSL 新治疗与机制文 献监测

近 7 天官方 PubMed 窗口：2026-06-05 至 2026-06-11。每篇文章单独成页，按 “标题、结论、主要内容、关键信息、启示” 快速浏览；启示严格区分已验证证据、作者观点和我的推断。

EDAT 新入库 37	PDAT 发表日期 26	MDAT 记录更新 255	精选入页 5
----------------	-----------------	------------------	-----------

固定公网主页：<https://zhengyipharmacy-collab.github.io/pubmed-lymphoma-slides/>

- 下载 PDF
- 下载 PPTX

检索与筛选说明

PubMed 官方 ESearch/EFetch 于 2026-06-11 检索；窗口为 2026-06-05 至 2026-06-11，合并 EDAT、PDAT、MDAT 覆盖近 7 天新增、发表和记录更新。官方计数为 EDAT 37、PDAT 26、MDAT 255，去重候选池 262 条。本日沿用 5 papers/day 和 pubmed-history.json 去重，选择 5 篇未跨日重复 PMID；MDAT-only 条目均明确标注为记录更新而非本周新发表。今日未重复纳入昨日已覆盖的 polatuzumab/loncastuximab ADC 条目，ADC 方向继续由近日本地历史页追踪。

检索式：((DLBCL[Title/Abstract] OR "diffuse large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR "large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR LBCL[Title/Abstract] OR PCNSL[Title/Abstract] OR "primary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "primary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR CNSL[Title/Abstract] OR "central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract]) AND lymphoma[Title/Abstract])

覆盖方向：BTKi、双抗、CAR-T/细胞治疗、ADC、免疫治疗、靶向联合、病例/病例系列、基础/机制/转化、耐药、CNS 穿透/药代、安全性和真实世界。

#	方向	疾病	PMID	标题	打开链接
1	BTKi / CNSL / CSF ctDNA	初治 PCNSL	42265756	PCNSL: R-MO/orelabrutinib 诱导治疗中，CSF ctDNA 清除或优于中期 PET-CT 预测早期疗效	打开文献
2	一线强度 / DLBCL / 真实世界回顾	年轻高危初治 DLBCL	42266738	年轻高危初治 DLBCL: R-DA-EPOCH 相比 R-CHOP 仅显示 CR 趋势，毒性和支持治疗负担更高	打开文献
3	CAR-T / 双抗 / 靶向治疗综述	转化滤泡性淋巴瘤，常按 DLBCL-like 处理	42265975	转化 FL 的新兴治疗证据图谱：CAR-T、CD20xCD3 双抗和 selinexor 的序贯框架	打开文献
4	CAR-T / axi-cel / 真实世界	R/R LBCL	42134094	MENA 地区 R/R LBCL 的 axi-cel 真实世界结果：疗效接近注册研究，骨髓受累和 LDH 仍是风险信号	打开文献
5	机制研究 / 基因组稳定性 / DLBCL 预后	GC 来源 B 细胞淋巴瘤 / DLBCL	42261377	Lamin B1 保护 B 细胞基因组稳定性：低 LMNB1 与 DLBCL 不良结局相关	打开文献

PCNSL：R-MO/orelabrutinib 诱导治疗中，CSF ctDNA 清除或优于中期 PET-CT 预测早期疗效

CSF ctDNA Molecular Clearance as a Prognostic Biomarker for Orelabrutinib-Treated Primary Central Nervous System Lymphoma: Insights From Comparison With PET-CT.

BTKi / CNSL / CSF ctDNA 初治 PCNSL EDAT/PDAT/MDAT 命中：2026-06-11 近 7 天新增入库/发表/更新

PMID 42265756

打开 PubMed 文献

P 接受 R-MO 诱导治疗的新诊断 PCNSL 患者

I 治疗过程中连续监测 CSF ctDNA，并观察中期分子清除

C 中期 PET-CT 评估及未清除/清除状态之间的比较

O 完全缓解、PFS、早期疗效预测能力

结论

这项前瞻性生物标志物研究显示，在接受 R-MO 诱导治疗的初治 PCNSL 患者中，治疗中期 CSF ctDNA 清除与完全缓解和更好的 PFS 显著相关，并且在该队列中的预测价值强于中期 PET-CT。该结果把 PCNSL 的早期疗效判断从影像评估推进到脑脊液分子清除层面。

主要内容

- 研究对象是接受 R-MO 诱导治疗的新诊断 PCNSL；其中 Orelabrutinib 代表 BTK 抑制剂暴露，是本日 CNSL/BTKi 方向最直接的新增信号。
- 作者连续监测 CSF ctDNA，并将治疗中期分子清除状态与完全缓解、PFS 和中期 PET-CT 结果进行比较。
- 摘要显示，中期 ctDNA 清除与完全缓解和较优 PFS 显著相关；在该队列中，预测早期疗效的能力强于中期 PET-CT。
- 研究类型为 Letter/前瞻性 biomarker 研究，重点是响应评估工具，不是随机比较不同 PCNSL 治疗方案。

关键信息

- 作者：Lixia Sheng、Huijie Hu、Yanli Lai、Shuyan Wang、Di Wang、Shanhao Tang 等。
- 核心变量：CSF ctDNA 连续监测、分子清除、完全缓解、PFS、中期 PET-CT、R-MO 诱导。
- 研究价值：为 PCNSL 中 BTKi 方案的早期停留/换策窗口提供可量化分子指标。
- 方向标签：PCNSL、BTKi、orelabrutinib、CSF liquid biopsy、ctDNA clearance、response assessment。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要明确记录，治疗中期 CSF ctDNA 清除与完全缓解和更优 PFS 显著相关，并且在本队列中预测价值强于中期 PET-CT。

论文作者观点

论文作者观点：CSF ctDNA 清除是 PCNSL 早期疗效评估中有前景的分子生物标志物，可补充或优于影像学中期评估。

我的推断

我的推断：后续 PCNSL/BTKi 研究可预设 CSF ctDNA 清除作为早期分层或适应性治疗变量；但目前仍是 biomarker 信号，不能直接写成治疗决策规则。

年轻高危初治 DLBCL：R-DA-EPOCH 相比 R-CHOP 仅显示 CR 趋势，毒性和支持治疗负担更高

PMID 42266738

打开 PubMed 文献

A study comparing the efficacy of R-CHOP and R-DA-EPOCH regimens in young, high-risk treatment-naïve diffuse large B-cell lymphoma patients: a multicenter retrospective analysis.

一线强度 / DLBCL / 真实世界回顾	年轻高危初治 DLBCL	EDAT/MDAT 命中：2026-06-11 近 7 天新增入库/更新
P 年轻、初治、高危 DLBCL 患者	I R-DA-EPOCH 一线治疗	C R-CHOP 一线治疗
		O CR、ORR、剂量强度、减量、治疗延迟、支持治疗和住院负担

结论

这项 5 家三级医院、148 例年轻高危初治 DLBCL 的多中心回顾研究显示，R-DA-EPOCH 组 CR 率数值高于 R-CHOP 组，但未达到统计学显著；同时 R-DA-EPOCH 的相对剂量强度更低，减量、延迟、G-CSF 使用、血小板输注和住院时间均更高。它支持把 “强化一线是否值得” 拆成疗效趋势、剂量可达性和支持治疗负担三件事来评估。

主要内容

- 研究纳入 2023-03 至 2025-03 的 148 例年轻、初治、高危 DLBCL，R-CHOP 98 例，R-DA-EPOCH 50 例。
- 两组基线总体平衡，但 R-DA-EPOCH 组 ECOG 1 比例更高，作者用多变量分析处理这一差异。
- CR 率为 46.0% vs 36.7%，ORR 为 58.0% vs 61.2%，差异未达到统计学显著；亚组中 R-DA-EPOCH 多数显示更高 CR 趋势但未显著。
- R-DA-EPOCH 组相对剂量强度更低，减量、延迟、G-CSF 使用、血小板输注和住院时间更高，提示强化方案的可实施性是关键限制。

关键信息

- 作者：Hui Lan、Yannong Ding、Min Liu。
- 核心数据：148 例；R-CHOP 98 例、R-DA-EPOCH 50 例；CR 46.0% vs 36.7%；ORR 58.0% vs 61.2%。
- 安全/实施信号：R-DA-EPOCH 组剂量强度下降、减量和治疗延迟增加，支持治疗资源需求更高。
- 方向标签：DLBCL、frontline intensity、R-CHOP、R-DA-EPOCH、young high-risk、supportive care burden。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要记录了样本量、两组构成、CR/ORR、剂量强度下降以及减量、延迟、G-CSF、输注和住院负担增加。

论文作者观点

论文作者观点：R-DA-EPOCH 在年轻高危初治 DLBCL 中有更高 CR 的趋势，但未显著，且血液学毒性和支持治疗负担更高，方案选择需权衡风险收益。

我的推断

我的推断：强化一线研究不能只看 CR 数值，应同步记录剂量强度、延迟、住院天数和支持治疗资源；当前回顾性证据不足以替代前瞻性分层验证。

转化 FL 的新兴治疗证据图谱：CAR-T、CD20xCD3 双抗和 selinexor 的序贯框架

Beyond Chemoimmunotherapy: Emerging Cellular and Targeted Therapies in Transformed Follicular Lymphoma: A Scoping Review.

CAR-T / 双抗 / 靶向治疗综述

转化滤泡性淋巴瘤，常按 DLBCL-like 处理

EDAT/MDAT 命中：2026-06-11 近 7 天新增入库/更新

PMID 42265975

打开 PubMed 文献

P 组织学确认或高度疑似 transformed follicular lymphoma 成人患者

I CAR-T、CD20xCD3 双抗、selinexor 等新兴细胞/靶向治疗

C 不同治疗类别、不同治疗线数和 CAR-T 后/不可及场景

O ORR、CR、CRS、序贯位置、证据缺口

结论

这篇 PRISMA-ScR 范式的 scoping review 纳入 17 项研究，约 222 例可提取结局的 transformed follicular lymphoma 患者，覆盖 CAR-T、CD20xCD3 双抗和 selinexor。作者提出阶梯式框架：转化时采用 DLBCL-like 诱导，适合且化疗敏感者考虑 ASCT，首次复发优先考虑 CAR-T，CAR-T 后或细胞治疗不可及时考虑双抗，后线可考虑 selinexor；同时强调仍缺少包含 t-FL 的前瞻性研究。

主要内容

- 研究按 PCC 框架定义人群和概念，聚焦组织学确认或高度疑似转化 FL 成人患者，排除传统化免以外的新兴治疗证据碎片。
- 17 项研究覆盖三类治疗：CAR-T 7 项 interventional trials，报告子集中 t-FL n=130；CD20xCD3 双抗可提取结局 n=61；selinexor n=31。
- CAR-T 在研究中 ORR 52-83%、CR 40-58%；真实世界 CAR-T 系列 ORR 82-92%、CR 64-67%。
- 双抗在重度预处理疾病中仍有活性：epcoritamab ORR 50%/CR 44%，glofitamab ORR 55%/CR 35%；CRS 以低级别为主。

关键信息

- 作者：Abdulrahman F Al-Mashdali、Rola Ghasoub、Shrouq Hwafdeh、Mohamed A Yassin。
- 核心价值：把 CAR-T、双抗和 selinexor 放到转化 FL 的实际序贯位置，而不是只列药物反应率。
- 证据层级：综述和子集数据为主，前瞻性、t-FL 专属或 biomarker-guided sequencing 证据不足。
- 方向标签：transformed FL、DLBCL-like、CAR-T、CD20xCD3 bispecific、epcoritamab、glofitamab、selinexor、sequencing。

启示

已验证证据
已验证证据：PubMed 摘要记录了 17 项研究、三类治疗、约 222 例可提取结局，以及 CAR-T、双抗、selinexor 的 ORR/CR 范围。

论文作者观点
论文作者观点：当前证据支持阶梯式治疗框架，但需要更多纳入 t-FL 的前瞻性试验来优化治疗选择和生物标志物指导的序贯。

我的推断
我的推断：每日监测中，转化 FL 应与 R/R DLBCL 共同追踪 CAR-T/双抗序贯和真实世界可及性；但综述框架不能写成具体个体治疗推荐。

MENA 地区 R/R LBCL 的 axi-cel 真实世界结果：疗效接近注册研究，骨髓受累和 LDH 仍是风险信号

Real-world outcomes of Axicabtagene Ciloleucel CAR-T therapy in large B-cell lymphoma: a single-center observational study.

CAR-T / axi-cel / 真实世界

R/R LBCL

MDAT 命中：近 7 天 PubMed 记录更新，非本周新发表

PMID 42134094

打开 PubMed 文献

P MENA 地区单中心接受 axi-cel 的 R/R LBCL 患者

I axi-cel CD19 CAR-T

C 二线 vs 三线及以后：不同预后变量分层

O ORR、CR、OS、PFS、CRS、ICANS、骨髓受累和 LDH 风险

结论

这项来自沙特单中心的观察性研究纳入 77 例接受 axi-cel 的 R/R LBCL 患者，最佳 ORR 78%、CR 49%，12 个月 OS 全组 71.4%，二线队列 86.2%、三线及以后 57%。骨髓受累缺失和 LDH 水平在多变量分析与 OS 相关；CRS 发生率高但重度比例较低，ICANS 重度比例需要关注。它为非欧美地区 CAR-T 真实世界实施提供了地区性补充。

主要内容

- 研究地点为 King Faisal Specialist Hospital and Research Center，时间为 2023-02 至 2024-11，属于 MENA 地区单中心真实世界数据。
- 77 例 R/R LBCL 中位年龄 53 岁，75% 为 IV 期，34% 有骨髓受累。
- 最佳 ORR 78%，CR 49%；二线和三线及以后 CR 率相近，但 OS 倾向于二线更优。
- CRS 发生率 94%，3 级及以上 4%；ICANS 发生率 39%，3 级及以上 17%，提示神经毒性管理仍是实施窗口。

关键信息

- 作者：Khalid Alsuhaibani、Amal Hejab、Maha Aljasser、Tusneem Elhassan、Syed Osman Ahmed、Walid Rasheed 等。
- 核心数据：77 例；ORR 78%、CR 49%；12 个月 OS 全组 71.4%，二线 86.2%，三线及以后 57%。
- 风险变量：骨髓受累、LDH 升高和晚期疾病被作者视为不良预后信号。
- 方向标签：axi-cel、CD19 CAR-T、R/R LBCL、real-world、MENA、CRS、ICANS、access and center experience。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要记录了 77 例真实世界 axi-cel 队列、ORR/CR、12 个月 OS、骨髓受累/LDH 风险信号以及 CRS/ICANS 发生率。

论文作者观点

论文作者观点：MENA 地区 axi-cel 的真实世界安全性和疗效与 ZUMA-1/ZUMA-7 注册研究相近，骨髓受累、LDH 和晚期疾病是不良预后标志。

我的推断

我的推断：CAR-T 真实世界研究应持续记录治疗线数、地区/中心经验、骨髓受累、LDH 和神经毒性管理；这类数据适合支持路径设计，不应直接外推为跨地区疗效等同。

Lamin B1 保护 B 细胞基因组稳定性：低 LMNB1 与 DLBCL 不良结局相关

Lamin B1 safeguards the B cell genome and shapes lymphoma outcome.

PMID 42261377

打开 PubMed 文献

机制研究 / 基因组稳定性 / DLBCL 预后

GC 来源 B 细胞淋巴瘤 / DLBCL

EDAT/PDAT/MDAT 命中：2026-06-11 近 7 天新增入库/发表/更新



GC B 细胞模型、人 DLBCL 数据及 B 细胞来源淋巴瘤相关样本



Lamin B1 条件性低表达/缺失与双链断裂定位分析



Lamin B1 保留 vs 低表达/缺乏：低 LMNB1 vs 较高 LMNB1



DNA 损伤、转录谱、双链断裂热点、DLBCL 临床结局

结论

这项 HemaSphere 研究用体内外 B 细胞模型和 sBLISS 双链断裂测序显示，Lamin B1 下调会增加 DNA 损伤并扰乱转录谱；在 Lamin B1 缺乏的鼠和人 GC B 细胞中，双链断裂热点非随机地靠近转录起始位点和调控元件。低 LMNB1 表达与 DLBCL 患者较差临床结局相关，提示核纤层-基因组稳定性轴可能是 DLBCL 发生发展和预后分层的机制线索。

主要内容

- GC B 细胞在适应性免疫反应中既进行克隆扩增和免疫球蛋白位点程序性 DNA 损伤，也会下调 Lamin B1。
- 作者使用条件性低表达 Lamin B1 的体内外 B 细胞模型，观察到 DNA 损伤增加和转录谱紊乱。
- sBLISS 结果显示，Lamin B1 缺乏时双链断裂热点非随机，偏向转录起始位点和调控翻译/mRNA fate 的元件附近。
- 低 LMNB1 表达与 DLBCL 患者不良临床结局相关，把基础机制与患者预后连接起来。

关键信息

- 作者：Filip Filipisky、Katarina B Chapman、Johannes Bloehdorn、Oscar Maiques、Abigail Lee、Andrew Clear 等。
- 核心技术：条件性 Lamin B1 低表达模型、体内/体外 B 细胞系统、sBLISS 双链断裂定位、DLBCL 结局关联。
- 机制重点：核纤层结构、基因组组织、转录控制、GC B 细胞 DNA 损伤和恶性转化风险。
- 方向标签：DLBCL、LMNB1、Lamin B1、genomic stability、germinal center B cells、DNA damage、outcome biomarker。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要记录了 Lamin B1 低表达导致 DNA 损伤增加、转录谱扰动、非随机双链断裂热点，以及低 LMNB1 与 DLBCL 较差结局相关。

论文作者观点

论文作者观点：Lamin B1 在保护 B 细胞基因组稳定性中具有关键作用，其缺失可能影响 B 细胞来源恶性肿瘤的发生和结局。

我的推断

我的推断：DLBCL 转化研究可把核结构、DNA 损伤定位和转录调控纳入风险分层假设；但 LMNB1 目前更像机制/预后线索，不是已验证治疗靶点。

今天的信号不是单一药物热点，而是“疗效前移 + 治疗可及 + CNS/微环境分层 + 安全管理”同步推进

已验证证据 本轮官方候选池 262 条，精选 5 篇未跨日重复 PMID： 42265756、42266738、42265975、42134094、42261377。 覆盖 PCNSL/BTKi/CSF ctDNA、年轻高危 DLBCL 一线强度、转化 FL 的 CAR-T/双抗/靶向序贯、axi-cel 真实世界结果，以及 Lamin B1-DNA 损伤-DLBCL 结局机制。	论文作者观点 入选论文作者共同强调的方向是：治疗方案评估正在从单一有效率扩展到早期分子清除、剂量可达性、支持治疗负担、细胞/双抗序贯、地区真实世界可实施性，以及机制性预后分层。	我的推断 我的推断是，后续每日监测应优先捕捉能改变研究设计变量的条目：PCNSL 的 CSF 分子清除，DLBCL 一线强化的可实施性指标，CAR-T/双抗/靶向药物的序贯位置，CAR-T 地区真实世界路径，以及 DNA 损伤/核结构等机制性分层；病例报告和纯诊断条目可保留，但优先级应低于能形成方案设计变量的研究。
下一次优先跟进 继续观察 frontMIND OS/ctDNA、PCNSL 双抗 CNS 穿透验证、双抗治疗中 PET 动态指标、CAR-T 可及性和桥接前 MTV 变化。	设计启示 DLBCL/CNSL 研究应同时记录疗效、到达治疗的路径、CNS/CSF 指标、影像负荷、分子/微环境分层和感染/神经毒性安全窗口。	边界提醒 本页仅作文献监测、证据摘要和方案设计启示整理，不提供医疗建议，也不生成治疗推荐。